

GANGRENA DE FOURNIER

Susana Ochoa Vilor, Manuel Ángel Ochoa Vilor, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Proceso infeccioso polimicrobiano intraescrotal que evoluciona de manera rápida como una fascitis necrotizante perineo-genital. Puede extenderse a pared abdominal anterior y miembros inferiores. Presenta una mortalidad cercana al 50%.

Los principales factores predisponentes son:

- Inmunosupresión: diabetes mellitus, cirrosis, neutropenia o VIH.
- Traumas penetrantes, contundentes o laceraciones.
- Cirugías urológicas o sondajes recientes.
- Otros: Obesidad o alcoholismo.

DIAGNÓSTICO

- **Clínico:**
 - Intenso dolor.
 - Signos inflamatorios: Edema, eritema, enfisema y crepitación, engrosamiento de cubiertas testiculares y fluctuación. Pueden existir supuración espontánea y necrosis que alcanza la piel.
 - Fiebre, taquicardia e hipotensión.
- **Pruebas complementarias:**
 - Analítica sanguínea: Hemograma con formula leucocitaria. Coagulación básica. Bioquímica con reactantes de fase aguda: PCR, Lactato, Procalcitonina con función renal y hepática.
 - Hemocultivos previo al inicio de la antibioterapia.
 - Sistemático y sedimento de orina y urocultivo.
 - Cultivo local.
 - Gasometría venosa.
 - TAC: Se identifica gas a lo largo de los planos fasciales. Útil para delimitar la afectación. Nunca debe retrasar la cirugía.



TRATAMIENTO

- **Medidas generales:**
 - Estabilización hemodinámica con fluidoterapia y vasopresores si se precisan.
 - AVISAR UROLOGÍA.
- **Analgesia.**
- **Antibioterapia de amplio espectro:**
 - Triple terapia: CEFALOSPORINAS 3^aG ± AMINOGLUCÓSIDOS + PENICILINA BENZATÍNICA + METRONIDAZOL O CLINDAMICINA
 - Monoterapia con Betalactámicos de amplio espectro (PIPERACILINA-TAZOBACTAN)
 - Carbapenémicos (ERTAPENEM, MEROPENEM) ± Metronidazol
- **Desbridamiento quirúrgico.** Tratamiento definitivo. En ocasiones se requiere orquiectomía, cistectomía o colostomías.

PUNTOS CLAVE

- La gangrena de Fournier es una entidad grave pero el pronóstico mejora con el diagnóstico temprano, el desbridamiento quirúrgico urgente y el inicio precoz de la antibioterapia de amplio espectro.

BIBLIOGRAFÍA

- Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing Soft-Tissue Infections. N Engl J Med 2017; 377:2253.
- Stevens DL, Baddour LM. Necrotizing soft tissue infections. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.
- Robert C Eyre, MD. Evaluation of acute scrotal pain in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.
- Smith GL, Bunker CB, Dinneen MD. Fournier's gangrene. Br J Urol 1998; 81: 347-55.